

— SANTÉ DIGESTIVE FÉMININE

SIBO : *comprendre,* tester, agir.

Le guide que vous auriez voulu avoir dès le début — physiologie claire, protocole dans le bon ordre, et le lien avec vos hormones qu'on ne vous a jamais expliqué.

Par **Sabrina Castelli** — Naturopathe, ancienne patiente SIBO
12 ans en R&D micronutrition · Spécialiste santé digestive & hormonale

SOMMAIRE

Ce que vous allez trouver ici.

INTRO	Mon histoire avec le SIBO — pourquoi ce guide existe	04
PARTIE 1	<i>Comprendre</i>	
	01 · Ce qui se passe vraiment dans votre intestin grêle	06
	02 · Pourquoi ça arrive — les vrais déclencheurs	09
	03 · Les 3 types de SIBO — et pourquoi ça change tout	12
	04 · SIBO et hormones — le lien qu'on ne vous a jamais expliqué	15
PARTIE 2	<i>Tester</i>	
	05 · Le test respiratoire — comment le demander, le préparer, le lire	20
	Fiche imprimable : Lire mes résultats	24
PARTIE 3	<i>Agir</i>	
	06 · Le protocole dans le bon ordre — ne pas brûler les étapes	26
	07 · Alimentation — pas un régime, une stratégie	30
	08 · Les plantes, la motilité, et la suite	35
PARTIE 4	<i>Votre histoire</i>	
	Fiche imprimable : Ma timeline SIBO	40
	Glossaire	42
	Bibliographie & sources scientifiques	45

AVANT DE COMMENCER

Mon histoire avec le SIBO.

Ce guide, je l'ai écrit avec la frustration de celle qui a cherché des réponses pendant trop longtemps — et la précision de celle qui a passé douze ans à comprendre ce qui se passe dans les cellules.

Quand mes propres symptômes ont commencé — les ballonnements qui venaient sans raison, la fatigue chronique, le transit imprévisible — j'avais déjà une formation scientifique solide. Je travaillais en R&D sur les compléments alimentaires. Je connaissais la physiologie digestive dans ses détails. Et pourtant, j'ai mis du temps à faire le lien avec le SIBO. Comme tout le monde.

Parce que le SIBO n'est pas enseigné. Pas en médecine générale, pas dans la plupart des écoles de naturopathie. On parle de "colon irritable", d'"hypersensibilité viscérale", de "stress". On prescrit des probiotiques — parfois la pire chose à faire en cas de SIBO hydrogène. On rassure, on normalise, on envoie chercher ailleurs.

CE QUE J'AI VOULU CRÉER

"Un guide que n'importe quelle femme peut lire sans formation scientifique — et qui lui donne enfin les mots pour comprendre ce qui se passe dans son corps."

Vous trouverez ici la physiologie expliquée simplement, le protocole dans le bon ordre (pas dans n'importe quel ordre — ça a de l'importance), et quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les ressources francophones : le lien entre le SIBO et vos hormones. SOPK, SPM, périménopause, endométriose — ces pathologies et le SIBO se nourrissent mutuellement. Comprendre l'une, c'est commencer à comprendre les autres.

Ce guide n'est pas un traitement. Il ne remplace pas une consultation. Mais il vous donnera les bases pour ne plus jamais repartir d'un cabinet médical les mains vides.

Sabrina Castelli

Naturopathe · Porto-Vecchio, Corse

PREMIÈRE PARTIE

Comprendre

*La physiologie claire. Ce qui se passe
vraiment dans votre corps, pourquoi ça
arrive, et le lien avec vos hormones.*

1

CHAPITRE 01

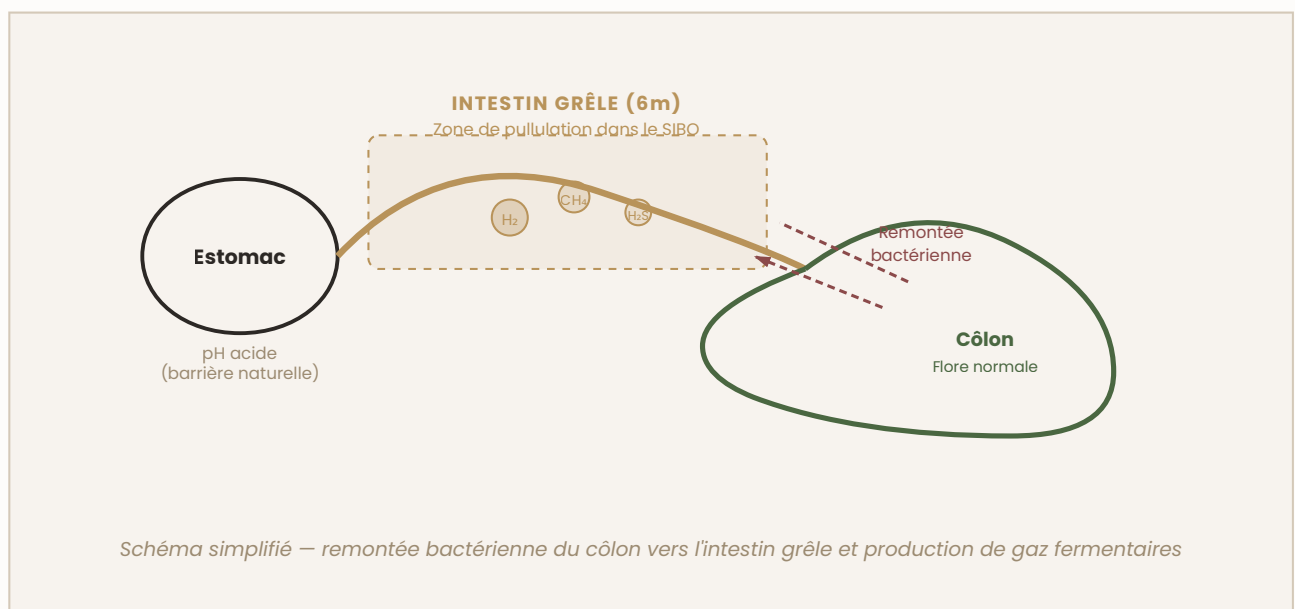
Ce qui se passe vraiment là-dedans.

Le SIBO n'est pas une maladie du côlon. C'est une pullulation bactérienne dans un endroit où il ne devrait y avoir quasiment aucune bactérie : votre intestin grêle.

L'ANATOMIE EN DEUX MOTS

Votre tube digestif est long d'environ 8 mètres. L'intestin grêle en occupe les 6 premiers — c'est lui qui absorbe les nutriments. Il est naturellement peu peuplé en bactéries (moins de 10^3 UFC/mL). Le côlon, lui, est dense en bactéries (10^{11} UFC/mL) — c'est normal et nécessaire.

Dans le SIBO, des bactéries du côlon remontent et colonisent l'intestin grêle. Résultat : elles fermentent les glucides que vous mangez *avant* que votre intestin ait eu le temps de les absorber. Cette fermentation produit des gaz — hydrogène (H_2), méthane (CH_4), ou sulfure d'hydrogène (H_2S) — selon le type de bactéries en cause.



CE QUE LES GAZ FONT À VOTRE MUQUEUSE

Ce n'est pas qu'une question de confort. La fermentation excessive dans l'intestin grêle provoque :

- **Distension et douleurs** — les gaz s'accumulent dans une zone peu extensible
- **Altération de la muqueuse** — les bactéries et leurs métabolites endommagent les entérocytes (cellules intestinales), réduisant l'absorption des nutriments

- **Hyperperméabilité intestinale** — la jonction serrée entre les cellules se relâche, laissant passer des molécules qui ne devraient pas franchir la barrière intestinale
- **Inflammation systémique** — le passage de fragments bactériens (LPS) dans la circulation déclenche une réponse inflammatoire à bas bruit, chronique

À RETENIR

Le SIBO n'est pas "juste" un problème de ballonnements. C'est une dysfonction qui, non traitée, contribue à la malabsorption des vitamines B12, D, fer et magnésium — et entretient une inflammation chronique qui retentit sur l'ensemble de l'organisme.

Sources : Pimentel M. et al. (2020) — ACG Clinical Guideline: SIBO. *Am J Gastroenterol.* / Ghoshal UC et al. (2017) — Small Intestinal Bacterial Overgrowth. *Gastroenterol Clin North Am.*

LES SYMPTÔMES — CE QUI DOIT VOUS ALERTER

Les symptômes du SIBO sont non-spécifiques, ce qui explique l'errance diagnostique. Ils incluent :

- Ballonnements, surtout en fin de journée ou après les repas

→ Douleurs abdominales diffuses ou crampes

→ Transit perturbé : diarrhée, constipation, ou alternance

→ Reflux gastro-œsophagien (SIBO et RGO sont fréquemment associés)

→ Nausées, satiété précoce
- Fatigue chronique inexplicquée (souvent liée à la malabsorption de B12 et fer)

→ Carences récurrentes malgré une alimentation équilibrée

→ Brouillard mental ("brain fog")

→ Intolérance aux FODMAPs, au lactose, au fructose

→ Symptômes qui s'aggravent avec les probiotiques

SIBO VS INTESTIN IRRITABLE VS CANDIDOSE — LE TABLEAU COMPARATIF

Ces trois entités sont souvent confondues, parfois coexistantes. Voici comment les distinguer cliniquement :

CRITÈRE	SIBO	INTESTIN IRRITABLE (SII)
Ballonnements	Marqués, surtout après repas riches en glucides, empirent en journée	Variables, souvent liés au stress et aux habitudes alimentaires
Test diagnostique	Test respiratoire lactulose/ glucose	Diagnostic d'exclusion (pas de test spécifique)
Probiotiques	Souvent aggravent les symptômes	Neutres ou bénéfiques selon les souches
Fatigue & carences	Fréquentes (malabsorption réelle)	Moins systématiques
Alimentation sans FODMAPs	Soulage temporairement mais ne traite pas la cause	Peut aider durablement

Source : Ford AC et al. (2020) — Functional Gastrointestinal Disorders. N Engl J Med. / Rezaie A. et al. (2017) — Hydrogen and Methane-Based Breath Testing. Am J Gastroenterol.

Si vous prenez des probiotiques et que vos symptômes *s'aggravent* ou déclenchent une montée d'histamine (rougeurs, palpitations, maux de tête), c'est un signal fort en faveur d'un SIBO. Les bactéries lactiques des probiotiques nourrissent la pullulation.

CHAPITRE 02

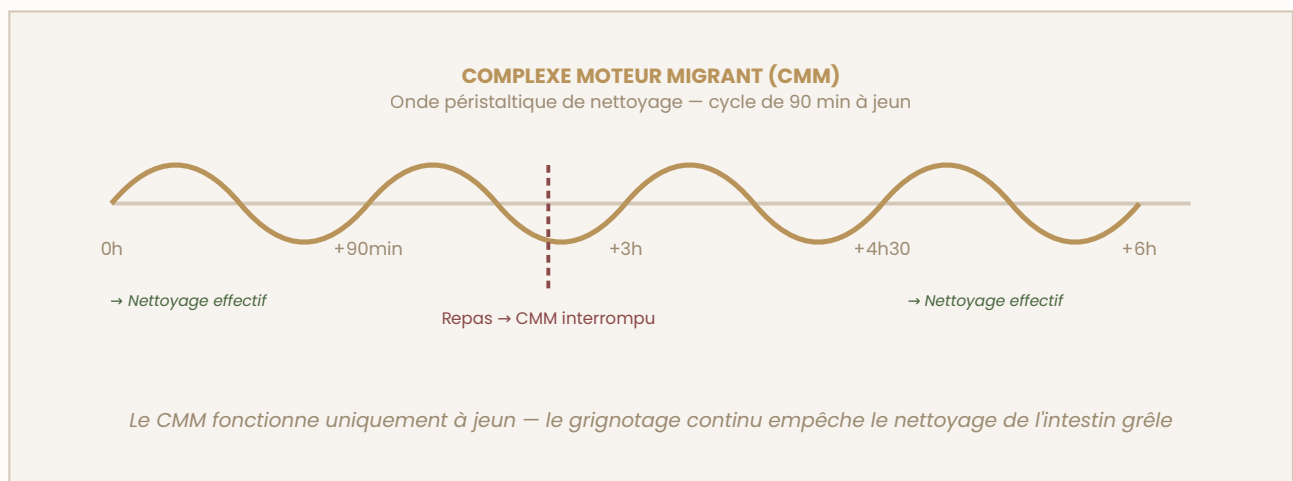
Pourquoi ça arrive.

Le SIBO n'arrive pas par hasard. Il y a toujours un "premier domino" — un événement qui a dérégulé l'un des mécanismes de protection de votre intestin grêle. Identifier le vôtre est essentiel pour éviter les récives.

LES MÉCANISMES DE PROTECTION NATURELS

L'intestin grêle dispose de trois barrières contre la pullulation bactérienne :

- 01 L'acidité gastrique** — l'acide chlorhydrique tue la majorité des bactéries ingérées avant qu'elles n'atteignent l'intestin grêle. La prise prolongée d'IPP (inhibiteurs de la pompe à protons) ou une hypochlorhydrie neutralisent ce mécanisme.
- 02 Les mouvements du CMM** (Complexe Moteur Migrant) — entre les repas, des contractions péristaltiques puissantes "balaient" l'intestin grêle toutes les 90 à 120 minutes. Ce mécanisme de nettoyage est altéré par le stress chronique, les troubles thyroïdiens, et les épisodes d'intoxication alimentaire.
- 03 La valvule iléo-cæcale** — cette valve empêche le reflux du contenu colique dans l'intestin grêle. Un dysfonctionnement (souvent lié à une dysbiose colique ou une inflammation) favorise le SIBO.



LES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS IDENTIFIÉS

MÉDICAMENTEUX

INFECTIONS & CHIRURGIE

IPP au long cours (oméprazole, pantoprazole) · Antibiotiques à large spectre (sans probiotiques après) · Opioïdes · Antidépresseurs (ralentissement motilité)

Gastro-entérite bactérienne sévère (ex. Campylobacter, Salmonelle) · Chirurgie abdominale · Appendicite · Tout événement créant des adhérences intestinales

HORMONAL & MÉTABOLIQUE

Hypothyroïdie (ralentit le CMM) · Diabète (neuropathie autonome) · SOPK · Grossesse · Pérимénopause · Excès ou déficit d'œstrogènes

STRESS & SYSTÈME NERVEUX

Stress chronique (inhibe le nerf vague et le CMM) · Traumatismes · Dysautonomie · Cycle veille/sommeil perturbé

POST-INFECTIEUX : LE SIBO LE PLUS FRÉQUENT

Environ 1 personne sur 3 développe un SIBO après une gastro-entérite bactérienne sévère. Les anticorps produits contre les bactéries pathogènes attaquent également la vinculine (protéine du CMM), créant des dommages durables à la motilité. C'est le mécanisme principal du SIBO-méthane (IMO).

Source : Pimentel M. et al. (2015) — Autoimmunity Links Vinculin to the Pathophysiology of Chronic Functional Bowel Changes. *Dig Dis Sci*.

CHAPITRE 03

Les 3 types — *et pourquoi ça change tout.*

Il n'y a pas "un" SIBO. Il y en a trois, selon le type de gaz produit. Et le traitement diffère selon le type — c'est pourquoi un test est indispensable avant tout protocole.

H₂**SIBO HYDROGÈNE**

Le plus fréquent — souvent associé à la diarrhée

Produit par des bactéries de type Bacteroidetes et Proteobacteria. Tableau clinique dominé par les ballonnements rapides après le repas, les diarrhées, les douleurs abdominales. Les femmes avec SOPK et endométriose sont surreprésentées dans ce profil.

CH₄**IMO — INTESTINAL METHANOGEN OVERGROWTH**

Souvent associé à la constipation chronique

Produit par des archées (Methanobrevibacter smithii), pas des bactéries au sens strict — d'où le terme IMO. Le méthane ralentit le transit en agissant directement sur la motilité intestinale. Tableau : constipation sévère, ballonnements bas, prise de poids difficile à expliquer. Fréquent après une gastro-entérite (mécanisme vinculine).

H₂S**SIBO SULFURE D'HYDROGÈNE**

Souvent sous-diagnostiqué — selles malodorantes, douleurs

Produit par Desulfovibrio. Longtemps non détectable par les tests standards (nécessite un test spécifique H₂S). Associé à des selles très malodorantes, des intolérances multiples, une hyperperméabilité marquée. Lien avec l'histaminose fréquent.

POURQUOI C'EST CRUCIAL DE TYPER

Le traitement du SIBO-H₂ (rifaximine seule) est différent du SIBO-CH₄ (rifaximine + néomycine, ou protokylol). En naturopathie, les plantes utilisées diffèrent également. Traiter sans connaître le type expose à un échec thérapeutique ou une aggravation.

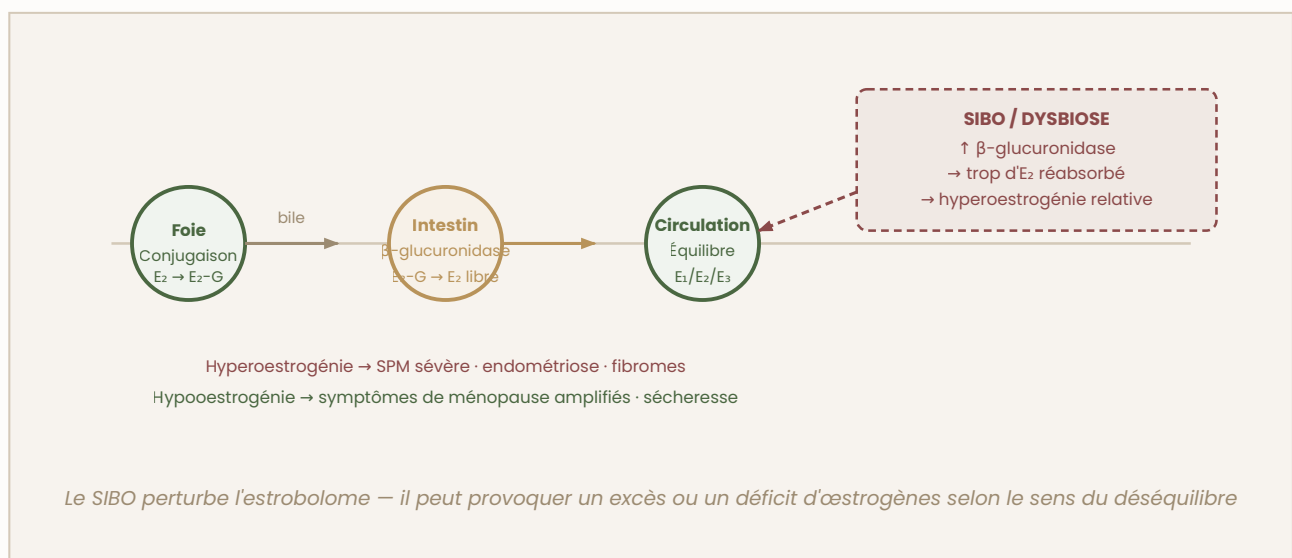
CHAPITRE 04

Le lien qu'on ne vous a jamais expliqué.

SIBO et déséquilibres hormonaux se nourrissent mutuellement. Ce n'est pas une coïncidence si les femmes souffrant de SOPK, d'endométriose, de SPM sévère ou de périménopause sont surreprésentées parmi les patientes SIBO.

L'ESTROBOLOME — VOTRE MICROBIOME MÉTABOLISE VOS ŒSTROGÈNES

L'estrobolome est l'ensemble des bactéries intestinales qui produisent la β -glucuronidase, une enzyme qui déconjugue les œstrogènes dans l'intestin pour leur permettre d'être réabsorbés dans la circulation. En cas de SIBO ou dysbiose, cet équilibre est perturbé :



LES 5 CONNEXIONS DOCUMENTÉES

- **SIBO et SOPK** — prévalence du SIBO significativement plus élevée chez les femmes SOPK. L'insulinorésistance et l'hyperandrogénie altèrent la motilité intestinale.
- **SIBO et endométriose** — l'inflammation systémique entretenue par le SIBO amplifie la réponse inflammatoire de l'endométriose. Lien bidirectionnel.
- **SIBO et SPM / PMDD** — l'hyperœstrogénie relative favorisée par un estrobolome perturbé aggrave les symptômes prémenstruels (humeur, rétention d'eau, douleurs).
- **SIBO et périménopause** — la chute des œstrogènes altère la motilité et la perméabilité intestinale, favorisant le SIBO. La symptomatologie de périménopause est souvent amplifiée.

→ **SIBO et thyroïde** — la malabsorption de sélénium, zinc et iode affecte la synthèse des hormones thyroïdiennes. Une hypothyroïdie non traitée ralentit le CMM et favorise le SIBO.

Sources : Takakura W. et al. (2020) — *Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome*. *Curr Gastroenterol Rep.* / Parida S. et al. (2019) — *The Microbiome–Estrogen Connection*. *Oncotarget*.

DEUXIÈME PARTIE

Tester

*Le test respiratoire : comment le demander,
le préparer, et enfin lire vos résultats sans
être médecin.*

2

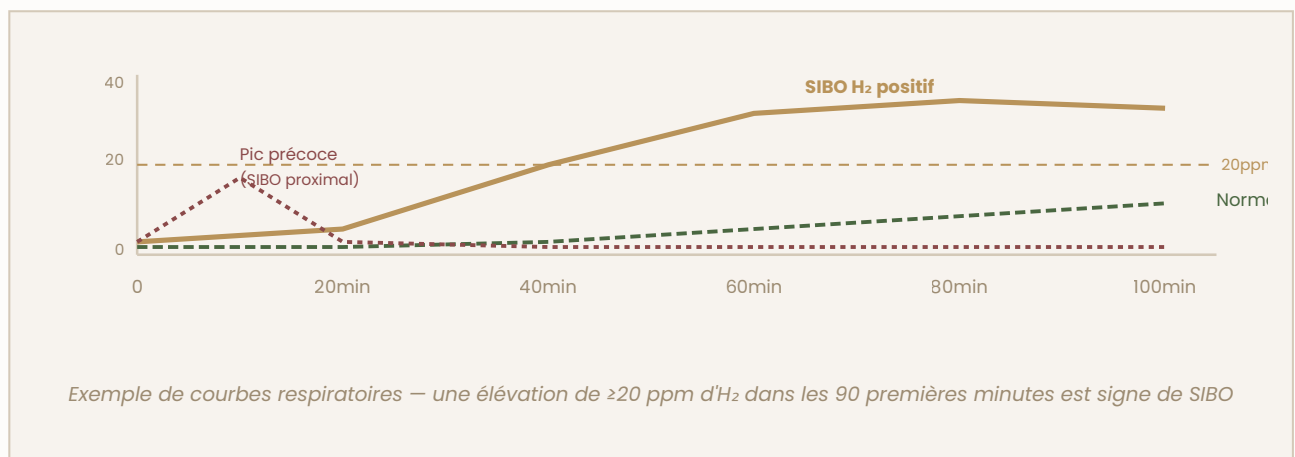
CHAPITRE 05

Le test respiratoire — *comment s'y retrouver.*

C'est actuellement la méthode de référence non invasive pour diagnostiquer le SIBO. On mesure les gaz que vous expirez après ingestion d'un substrat fermentescible — ce sont les bactéries de votre intestin grêle qui les produisent.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Vous ingérez du lactulose ou du glucose (les deux substrats les plus utilisés). Si des bactéries sont présentes dans votre intestin grêle, elles fermentent le substrat et produisent des gaz qui passent dans votre sang puis sont expirés. On les mesure en ppm (parties par million) toutes les 20 minutes pendant 2 à 3 heures.



COMMENT LE DEMANDER

En France, le test respiratoire SIBO n'est pas systématiquement proposé. Voici comment l'obtenir :

- **Via un gastro-entérologue** — demandez explicitement un "breath test lactulose ou glucose pour SIBO". Certains prescrivent facilement, d'autres résistent.
- **Via votre médecin traitant** — possible, mais moins courant. Présentez vos symptômes clairement et mentionnez le terme SIBO.
- **Via un laboratoire spécialisé en ligne** — des kits à domicile existent (Breath ID, Quintron). Résultats fiables, sans ordonnance.

CRUCIAL — UN MAUVAIS PRÉPARATION INVALIDE LE TEST

Éviter 24h avant : légumineuses, céréales complètes, fibres fermentescibles, lactose, fructose, alcool, probiotiques. **Éviter 4 semaines avant** : antibiotiques. **Le matin du test** : jeûne de 12h, pas de tabac, pas d'exercice intense.

FICHE IMPRIMABLE

Comprendre mes résultats de test respiratoire.

MES RÉSULTATS

SUBSTRAT UTILISÉ	DATE DU TEST	LABORATOIRE

TEMPS	H ₂ (PPM)	CH ₄ (PPM)	H ₂ S (SI DISPONIBLE)	INTERPRÉTATION
0 min (basal)				Valeur de référence
20 min				
40 min				
60 min				
80 min				
90 min				
120 min				

CLÉ DE LECTURE

CRITÈRE	SIGNE DE SIBO H ₂	SIGNE DE SIBO CH ₄ (IMO)
Élévation précoce (avant 90 min)	≥ 20 ppm au-dessus du basal	≥ 10 ppm au-dessus du basal
Double pic	Pic intestin grêle puis côlon	Possible
Basal élevé (>10 ppm H ₂)	Possible SIBO ou dysbiose colique – à interpréter avec les symptômes	

MES NOTES ET QUESTIONS À POSER

Cette fiche est un outil de compréhension, pas un diagnostic. Pour interpréter vos résultats dans le contexte de votre histoire, consultez un professionnel de santé formé au SIBO.

TROISIÈME PARTIE

Agir

Le protocole dans le bon ordre.

*L'alimentation comme stratégie. Les plantes,
la motilité, et la reconstruction.*

3

CHAPITRE 06

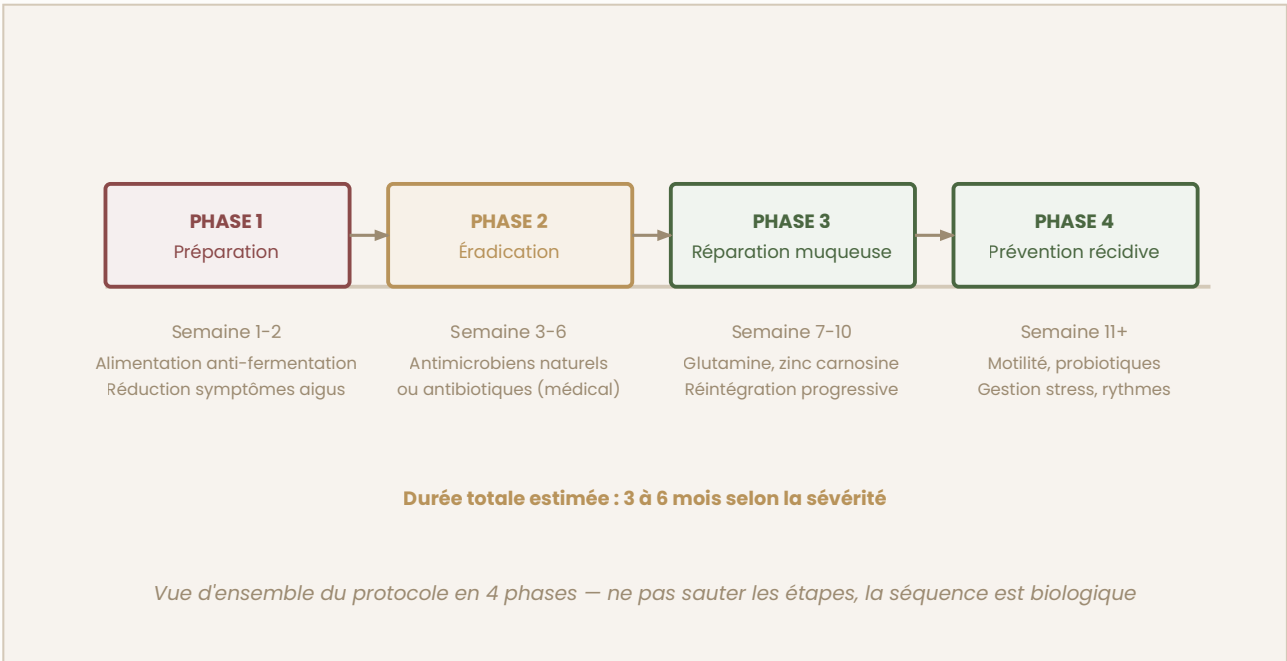
Le protocole — dans le bon ordre.

C'est là que beaucoup de femmes se perdent. Elles commencent par les probiotiques (erreur), ou attaquent trop vite la phase de réintroduction (récidive assurée). L'ordre a une logique biologique précise.

ERREUR LA PLUS FRÉQUENTE

Commencer par les probiotiques. En phase de pullulation active, les probiotiques — même de haute qualité — nourrissent les bactéries déjà en excès et aggravent les symptômes. Les probiotiques viennent après l'éradication.

LES 4 PHASES DANS L'ORDRE



PHASE 2 — LES ANTIMICROBIENS NATURELS LES PLUS DOCUMENTÉS

PLANTE / MOLECULE	ACTIF SUR	DOSAGE INDICATIF	PRÉCAUTIONS
Origan (carvacrol)	H ₂ & H ₂ S	200 mg × 3/j, 4 semaines	Éviter si grossesse. Puissant — commencer doucement.

Berberine	H ₂ , CH ₄	500 mg × 2/j, 4 semaines	Interactions médicamenteuses (anticoagulants). Pas seul pour CH ₄ .
Neem (extrait feuilles)	H ₂ , biofilms	300 mg × 2/j	Ne pas associer avec protocoles antifongiques forts.
Allicine (ail stabilisé)	CH ₄ (archées)	450 mg × 2/j	Seule option naturelle réellement efficace sur l'IMO.

Source : Chedid V. et al. (2014) — *Herbal Therapy Is Equivalent to Rifaximin for Treatment of SIBO*. Glob Adv Health Med.

PROTOCOLE NATUROPATHIQUE VS ANTIBIOTIQUES

L'étude Chedid 2014 montre une efficacité équivalente des protocoles à base d'herbes et de la rifaximine sur le SIBO-H₂. Pour l'IMO (CH₄), les données privilégient la combinaison rifaximine + néomycine en médical, et allicine + neem en naturopathie. Discutez avec votre praticien du meilleur choix pour votre profil.

CHAPITRE 07

L'alimentation — *pas un régime, une stratégie.*

Le régime Low-FODMAPs est souvent présenté comme "le régime SIBO". Ce n'est pas exactement ça. C'est un outil pour réduire la fermentation pendant le traitement — pas une solution à long terme ni une alimentation définitive.

COMPRENDRE LES FODMAPS

FODMAPs = Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Ce sont des glucides fermentescibles que vos bactéries adorent. Pendant la phase d'éradication, les réduire diminue la charge fermentaire et atténue les symptômes.

PHASE 1-2 · À RÉDUIRE

Légumineuses (pois chiches, lentilles) · Céréales riches en fructanes (blé, seigle, orge) · Oignons, ail, poireaux · Pommes, poires, mangues · Lait de vache (lactose) · Miel, sirop d'agave, fructose

PHASE 1-2 · À PRIVILÉGIER

Viandes, poissons, œufs · Riz, quinoa, avoine (petite quantité) · Courgette, carotte, concombre, épinards · Fraises, kiwi, orange, citron · Fromages à pâte dure · Huile d'olive, noix de coco

RÈGLE D'OR : L'ESPACEMENT DES REPAS

Laisser **4 à 5 heures** entre les repas sans grignotage permet au CMM de faire son travail de nettoyage. C'est souvent plus puissant que n'importe quelle restriction alimentaire. Le grignotage continu est l'une des causes majeures de récidence.

PLAN ALIMENTAIRE TYPE — SEMAINE 1-2 (PHASE PRÉPARATOIRE)

REPAS	EXEMPLES	NOTES
Petit-déjeuner	Œufs brouillés + riz soufflé + huile d'olive + herbes fraîches	Pas de lait. Éviter le pain de blé.
Déjeuner	Poulet grillé + riz + courgettes + huile olive + citron	Sauce soja en petite quantité ok.
Collation (si nécessaire)	Kiwi ou fraises + quelques noix de macadamia	Si seulement besoin réel. Pas systématique.

Dîner	Saumon vapeur + quinoa + épinards sautés + gingembre frais	Gingembre : prokinétique naturel doux.
--------------	---	---

PHOTO

Assiette colorée, cuisine méditerranéenne / anti-fermentation – ambiance Corse

Source : Gibson PR & Sheperd SJ (2010) — Evidence-based dietary management of functional GI symptoms. J Gastroenterol Hepatol. / Monash University FODMAP research.

CHAPITRE 08

Les plantes, la motilité, et la suite.

SOUTENIR LA MOTILITÉ — PRÉVENIR LA RÉCIDIVE

La récurrence est le talon d'Achille du SIBO. Environ 40% des personnes rechutent dans les 9 mois si on ne s'occupe pas du mécanisme sous-jacent. La motilité (CMM) est le point central à adresser en phase 4.

APPROCHE	MÉCANISME	FORME / UTILISATION
Gingembre (Zingiber officinale)	Prokinétique naturel — stimule le CMM et la vidange gastrique	Infusion racine fraîche, 2/j entre les repas · Extrait standardisé 500mg
Artichaut (Cynara scolymus)	Soutien hépatique et motilité intestinale — stimule la sécrétion biliaire	EPS (extrait glycéринé) · Gélules standardisées
Gentiane (Gentiana lutea)	Amer gastrique — stimule les sécrétions digestives et la motilité haute	Teinture mère, 20 gouttes avant le repas
Prokinétiques médecine	Mosapride, prucalopride (prescription) — si CMM sévèrement altéré	Sur prescription — à discuter avec médecin si récurrences multiples

LA RÉPARATION DE LA MUQUEUSE (PHASE 3)

Le SIBO abîme les entérocytes. Avant de réintroduire les fibres et probiotiques, il faut reconstruire la muqueuse :

- **L-Glutamine** — carburant des entérocytes. 5 à 10g/j à jeun le matin, 4 à 8 semaines
- **Zinc-carnosine** — répare les jonctions serrées et réduit l'hyperperméabilité. 75mg × 2/j
- **Colostrum bovin** — riche en IgA et facteurs de croissance intestinaux. 1 à 2g/j
- **Curcuma + pipérine** — anti-inflammatoire muqueux. Biodisponibilité cruciale → choisir un extrait micellaire ou avec pipérine

LE STRESS — L'OUBLIÉ DU PROTOCOLE

Le nerf vague est le chef d'orchestre de la motilité intestinale. Le stress chronique inhibe son tonus et paralyse le CMM. Aucun protocole SIBO n'est complet sans adresser la régulation du système nerveux autonome :

PRATIQUES DOCUMENTÉES

Cohérence cardiaque (3 fois/j, 5 min) · Yoga nidra · Marche lente en nature · Respiration diaphragmatique avant les repas

SOUTIEN ADAPTOGÈNE

Ashwagandha (400mg/j) · Rhodiola rosea (200mg matin) · Magnésium bisglycinate (300mg soir) · Complexe B actif (B1, B6-P5P, B12 méthylée)

LES PROBIOTIQUES — QUAND ET LESQUELS

Uniquement en phase 4, après l'éradication. Privilégier des souches *non-lactiques* dans un premier temps : **Saccharomyces boulardii** (non-bactérien, ne fermente pas), puis progressivement **Lactobacillus rhamnosus GG** et **Bifidobacterium longum**. Éviter les mélanges multi-souches standards en début de réintroduction.

Source : Leblhuber F. et al. (2018) — Probiotic Supplementation in Patients with Alzheimer's Dementia. Curr Alzheimer Res. / Pimentel M. (2012) — Review of rifaximin as treatment for SIBO and IBS. Expert Opin Investig Drugs.

QUATRIÈME PARTIE

Votre histoire.

*Placer vos symptômes sur une frise
chronologique pour identifier votre premier
domino.*

4

FICHE IMPRIMABLE

Ma timeline SIBO — *retrouver le premier domino.*

Placez sur cette frise les événements marquants de votre vie depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui.

Chirurgies, traitements antibiotiques longs, épisodes de stress intense, grossesses, changements hormonaux, gastro-entérites sévères, changements alimentaires...

Enfance	
Adolescence	
20-30 ans	
30-40 ans	
40-50 ans	
Aujourd'hui	

QUESTIONS POUR IDENTIFIER VOTRE PREMIER DOMINO

- ☐ Avez-vous eu une gastro-entérite sévère (fièvre, vomissements, diarrhée >48h) dans les 2-3 ans précédant le début de vos symptômes ?
- ☐ Avez-vous pris des antibiotiques à large spectre (plus de 10 jours) ?
- ☐ Avez-vous subi une chirurgie abdominale (appendicite, césarienne, occlusion...) ?
- ☐ Prenez-vous ou avez-vous pris des IPP (oméprazole, esoméprazole) au long cours ?
- ☐ Avez-vous une hypothyroïdie ou un trouble thyroïdien non traité ou mal équilibré ?

☐ Avez-vous vécu une période de stress intense ou un traumatisme avant le début des symptômes ?

☐ Avez-vous un SOPK, une endométriose, ou un déséquilibre hormonal diagnostiqué ?

Apportez cette frise complétée à votre première consultation – c'est l'outil le plus précieux pour remonter la cascade causale et construire un protocole adapté à votre histoire.

RÉFÉRENCE

Glossaire.

Les termes clés utilisés dans ce guide, expliqués simplement.

Archées	Micro-organismes distincts des bactéries, responsables de la production de méthane dans l'IMO. Methanobrevibacter smithii est l'archée prédominante dans l'intestin humain.
Béta-glucuronidase	Enzyme produite par certaines bactéries intestinales. Elle déconjugue les œstrogènes dans l'intestin, permettant leur réabsorption. En excès, elle contribue à l'hyperœstrogénie.
CMM (Complexe Moteur Migrant)	Onde péristaltique qui "balaie" l'intestin grêle entre les repas toutes les 90-120 minutes. Principal mécanisme de prévention du SIBO. Ne fonctionne qu'à jeun.
Dysbiose	Déséquilibre de la composition et de la fonction du microbiome intestinal. Peut précéder ou accompagner le SIBO.
Entérocytes	Cellules qui tapissent l'intestin grêle et assurent l'absorption des nutriments. Endommagés par les bactéries et les métabolites produits dans le SIBO.
Estrobolome	Ensemble des gènes bactériens du microbiome intestinal capables de métaboliser les œstrogènes. Détermine en partie les niveaux d'œstrogènes circulants.
FODMAPs	Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols. Glucides fermentescibles présents dans de nombreux aliments, qui nourrissent les bactéries en excès dans le SIBO.
Hypochlorhydrie	Réduction de la sécrétion d'acide chlorhydrique par l'estomac. Réduit la protection naturelle contre la pullulation bactérienne. Favorisée par les IPP, le vieillissement, le stress chronique.
Hyperperméabilité intestinale	"Leaky gut" — relâchement des jonctions serrées entre les entérocytes, permettant le passage de molécules normalement filtrées dans la circulation. Favorise l'inflammation systémique.
IMO	Intestinal Methanogen Overgrowth. Terme préféré à "SIBO-méthane" car les producteurs de méthane (archées) ne sont pas des bactéries au sens strict.
IPP	

leur usage prolongé est associé à un risque accru de SIBO.

LPS (lipopolysaccharides)	Fragments de paroi bactérienne. En cas d'hyperperméabilité, ils passent dans la circulation et déclenchent une réponse inflammatoire systémique à bas bruit.
Prokinétique	Substance (naturelle ou médicamenteuse) qui stimule la motilité intestinale — donc le CMM. Essentiel en phase 4 pour prévenir la récurrence.
SIBO	Small Intestinal Bacterial Overgrowth — pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Définition stricte : $>10^3$ UFC/mL dans l'intestin grêle proximal, ou élévation précoce de l'H ₂ au test respiratoire.
Valvule iléo-cæcale	Valve à la jonction intestin grêle / côlon. Préviend le reflux des bactéries coliques vers l'intestin grêle. Son dysfonctionnement favorise le SIBO.
Vinculine	Protéine structurelle du CMM. Des anticorps dirigés contre elle (produits après une gastro-entérite bactérienne) altèrent durablement la motilité intestinale — mécanisme principal du SIBO post-infectieux.

SOURCES SCIENTIFIQUES

Bibliographie.

Toutes les informations cliniques de ce guide sont fondées sur des études publiées dans des revues à comité de lecture. Les références principales sont listées ci-dessous.

- 1 Pimentel M. et al. (2020). ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. *Am J Gastroenterol*. 115(2):165–178.
- 2 Ghoshal UC, Shukla R, Ghoshal U. (2017). Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome: A Bridge between Functional Organic Dichotomy. *Gut Liver*. 11(2):196–208.
- 3 Rezaie A. et al. (2017). Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus. *Am J Gastroenterol*. 112(5):775–784.
- 4 Pimentel M. et al. (2015). Autoimmunity Links Vinculin to the Pathophysiology of Chronic Functional Bowel Changes Following *Campylobacter jejuni* Infection. *Dig Dis Sci*. 60(5):1195–1205.
- 5 Chedid V. et al. (2014). Herbal Therapy Is Equivalent to Rifaximin for the Treatment of Small Intestinal Bacterial Overgrowth. *Glob Adv Health Med*. 3(3):16–24.
- 6 Parida S, Sharma D. (2019). The Microbiome–Estrogen Connection and Breast Cancer Risk. *Cells*. 8(12):1642.
- 7 Takakura W, Pimentel M. (2020). Small Intestinal Bacterial Overgrowth and Irritable Bowel Syndrome — An Update. *Front Psychiatry*. 11:664.
- 8 Gibson PR, Shepherd SJ. (2010). Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. *J Gastroenterol Hepatol*. 25(2):252–258.
- 9 Ford AC et al. (2020). Functional Bowel Disorders. *Gastroenterology*. 158(5):1958–1972.
- 10 Carding SR et al. (2015). Dysbiosis of the gut microbiota in disease. *Microb Ecol Health Dis*. 26:26191.
- 11 Leblhuber F. et al. (2018). Probiotic Supplementation in Patients with Alzheimer's Dementia — An Explorative Intervention Study. *Curr Alzheimer Res*. 15(12):1106–1113.
- 12 Pimentel M. (2012). Review of rifaximin as treatment for SIBO and IBS. *Expert Opin Investig Drugs*. 21(4):475–482.
- 13 Monash University FODMAP Research Team. fodmapmonash.edu — Base de données des teneurs en FODMAPs.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si ce guide a soulevé plus de questions qu'il n'en a répondu, c'est normal — c'est le signe que vous avez une histoire complexe qui mérite une approche personnalisée. Je propose des consultations en visio depuis Porto-Vecchio, ouvertes à partir du 15 septembre. Vous pouvez déjà me contacter à **sabrina@avitaserena.com** ou consulter mes programmes sur **avitaserena.com**.

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est interdite.

Ce guide a un objectif éducatif et ne constitue pas un diagnostic médical ni un traitement.